



GUIA PARA PACIENTES

Dor na frente do joelho ao subir escada

dor patelofemoral e "condromalácia": o que um cirurgião de joelho gostaria que você soubesse

É uma das dores de joelho mais comuns em jovens e corredores. Entenda o que o laudo quer dizer de verdade, por que exercício de quadril e de joelho é a base do tratamento e por que a cirurgia raramente entra nessa conversa.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **ESCADA**

Para quem é:

Para quem sente dor **na frente do joelho**, em volta ou atrás da patela (a "rótula"), que piora ao **subir ou descer escada**, agachar, correr ou ficar muito tempo sentado com o joelho dobrado, e **não tem nenhum sinal de alerta da próxima página**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem já teve a patela **deslocada** ("saiu do lugar"): é outro problema, com outro tratamento.
- Quem operou o joelho recentemente: siga a orientação da sua equipe.
- Quem tem mais de 50 anos, com dor e rigidez no joelho todo: pode ser artrose, e a conversa é outra.
- Crianças em fase de crescimento com dor logo abaixo da patela: pedem avaliação própria.

O que você vai precisar:

- Um colchonete ou tapete firme.
- Uma cadeira firme, sem rodinhas.
- Um degrau baixo, de preferência com corrimão.
- Uma caneta para o rastreador da Página 8.

Regra de ouro:

Exercício com **incômodo leve**: sim. Dor **mais forte no dia seguinte** ou joelho **inchado**: reduza.

Patela que **sai do lugar** ou joelho que **trava**: pare tudo e leia a Página 3.

A dor na frente do joelho raramente é urgência. Mas algumas situações não podem esperar. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure atendimento HOJE se:

- O joelho está **quente, vermelho e inchado**, com **febre** ou calafrios. Pode ser infecção na articulação. A febre aparece em só cerca de metade dos casos [13]: joelho muito quente e dolorido, mesmo sem febre, merece avaliação no mesmo dia.
- Depois de queda, batida ou torção, você **não consegue apoiar o peso** e dar quatro passos, nem mancando. É um dos critérios usados para pedir radiografia e afastar fratura [14].

Procure o ortopedista o quanto antes (não espere semanas) se:

- A patela **saiu do lugar**, ou o joelho **falseia** com a sensação de que ela "escapa" para o lado. Isso sugere instabilidade da patela, que não é a dor patelofemoral comum (opinião clínica).
- O joelho **travou e não destrava**: ficou preso e não estica por completo, nem com ajuda (opinião clínica).
- O joelho **inchou muito**, principalmente nas primeiras horas depois de uma torção ou queda (opinião clínica).

Diferença importante: estalos e sensação de "areia" ao dobrar o joelho, **sem inchaço e sem falseio**, são comuns na dor patelofemoral e, sozinhos, não são sinal de alerta [1].

A patela trabalha como uma polia

A patela desliza num trilho na frente do fêmur: é a articulação **patelofemoral**, uma polia para o músculo da coxa. De forma simplificada: quanto **mais dobrado** o joelho e **mais peso** em cima dele, maior a carga sobre a patela. Por isso escada, agachamento e corrida incomodam tanto.

Como os especialistas definem

É uma dor **em volta ou atrás da patela**, que piora em pelo menos uma atividade com o joelho dobrado e o peso apoiado: **agachar, subir ou descer escada, correr, saltar** [1][4]. Doer ao ficar muito tempo sentado, ou ao levantar da cadeira, também é comum [1].

É muito frequente

Uma revisão de 23 estudos estimou que **mais de 1 em cada 5 pessoas** tem esse tipo de dor ao longo de um ano, e quase 3 em cada 10 adolescentes [5]. Os números variam bastante entre os estudos [1][5], mas a mensagem é clara: é comum em **jovens, adolescentes e quem corre ou salta**.

Por que aparece?

Não há uma causa única, e nem sempre se encontra uma [1]. Na prática, eu penso nela como **carga acima do que o joelho está tolerando naquele momento**: treino que aumentou rápido, muita escada, agachamento profundo, coxa e quadril destreinados (opinião clínica).

Um nome antigo para uma dor comum

"Condromalácia" quer dizer, ao pé da letra, **cartilagem amolecida**. Durante muito tempo, o termo foi usado como nome da dor na frente do joelho. O consenso internacional hoje prefere **"dor patelofemoral"** e trata "condromalácia patelar" como um sinônimo antigo [1].

Laudo não é sentença

- Num estudo com 64 pessoas com dor patelofemoral e 70 sem dor, de 14 a 40 anos, as pequenas alterações de cartilagem na ressonância apareceram **na mesma proporção nos dois grupos**. Nenhuma alteração do exame se associou à dor [7].
- Somando 63 estudos, alterações de cartilagem apareceram em **cerca de 1 em cada 10 adultos sem dor e sem lesão abaixo dos 40 anos**, e em mais de 4 em cada 10 a partir dos 40 [8].

Ou seja: "condromalácia" no laudo de uma pessoa jovem **não quer dizer desgaste grave**, nem artrose, nem que o joelho "está acabando".

Precisa de ressonância?

O diagnóstico é feito pela **conversa e pelo exame físico** [1]. Radiografia ou ressonância entram quando a história não encaixa, quando houve trauma, inchaço ou travamento, ou quando o resultado vai mudar a conduta (opinião clínica).

O que os estudos mostram

- Uma revisão Cochrane, com 31 estudos e 1.690 pessoas, concluiu que o exercício **pode reduzir a dor e melhorar a função** de forma importante. A qualidade das provas era baixa, mas a direção foi a mesma [9].
- Somar exercícios **de quadril** aos **de coxa** trouxe mais alívio e melhor função do que exercitar só a coxa, inclusive com 1 ano [10].

O que dizem os consensos e a diretriz

Dois consensos internacionais de especialistas (2016 e 2018) e a diretriz americana de fisioterapia (2019) concordam: **exercício, de preferência combinando quadril e joelho, é o tratamento principal** [2][3][4].

Ajustar a carga, e não parar

A diretriz também inclui orientar **quanto, quando e como** usar o joelho [4]. Em corredores, um estudo com 69 pessoas mostrou que **só a orientação sobre carga de treino** trouxe melhora parecida com a de quem também fez exercícios ou mudou a forma de correr [11].

Na prática (opinião clínica):

- **Escada:** use o corrimão. Ao subir, comece pela perna sem dor; ao descer, pela perna com dor.
- **Agachamento e academia:** reduza a profundidade por um tempo, sem abandonar o treino.
- **Corrida:** reduza o volume e as descidas; volte aos poucos.

A escolha destes três é opinião clínica, seguindo o princípio de combinar quadril e joelho [3][4]. Nos estudos, os programas costumavam ser orientados por fisioterapeuta; este guia não substitui essa orientação.

Regra da dor (orientação prática): dor até 3, numa escala de 0 a 10, que volta ao seu normal até a manhã seguinte, é aceitável.

Exercício 1 — Abertura lateral deitado (quadril)

Como fazer: deitado de lado, perna de baixo dobrada. Com a perna de cima esticada e alinhada ao corpo, eleve-a cerca de um palmo, segure 2 segundos e desça devagar. 3 séries de 10 a 15, dos dois lados.

Sensação correta: esforço na lateral do quadril.

Erro comum: girar a ponta do pé para cima ou levar a perna para a frente.

Exercício 2 — Ponte (quadril)

Como fazer: de barriga para cima, joelhos dobrados, pés apoiados. Eleve o quadril até alinhar joelhos, quadril e ombros. Segure 3 segundos e desça devagar. 3 séries de 10 a 12.

Sensação correta: glúteos trabalhando.

Erro comum: arquear a lombar para subir mais.

Exercício 3 — Agachamento parcial apoiado (joelho)

Como fazer: de pé, segurando o encosto de uma cadeira firme. Leve o quadril para trás, como quem vai sentar, e dobre os joelhos só até onde não doer, sem passar da metade. Suba devagar. 3 séries de 10.

Sensação correta: frente da coxa e glúteos trabalhando.

Erro comum: joelhos caindo para dentro ou descer fundo demais.

Semanas 1 e 2 — Acalmar e ajustar

- Ajustes da Página 6 (escada, agachamento, corrida).
- Exercícios 1 e 2, em dias alternados, 2 séries. Exercício 3 só se a dor permitir.

Semanas 3 e 4 — Fortalecer

- Exercícios 1, 2 e 3, em dias alternados, 3 séries.

Semanas 5 e 6 — Progredir

- Progrida **uma coisa de cada vez**: mais repetições **ou** descida mais lenta **ou** subida num degrau baixo, com corrimão.
- Quem corre: volta gradual, sem dor que piore no dia seguinte.

Os volumes são um ponto de partida prático, não um protocolo testado.

Seis semanas servem para começar e enxergar a tendência; muita gente precisa de mais tempo (opinião clínica).

Rastreador

	Dor na escada (0–10)	Dor máx. no exercício (0–10)	Sessões feitas	Pior no dia seguinte? (S/N)	Inchou ou falseou? (S/N)
Semana 1					
Semana 2					
Semana 3					
Semana 4					
Semana 5					
Semana 6					

Leve esta tabela para a consulta. Ela mostra ao médico a tendência, e não só o pior dia.

Este guia não indica remédio, injeção nem dose. Isso é decisão tomada na consulta.

Palmilha

Em quem tem o pé que "cai para dentro" (pronado), a palmilha pronta pode aliviar a dor **a curto prazo, por cerca de 6 semanas**, junto com o exercício [2][4]. Não há prova de que a palmilha sob medida seja melhor [4].

Bandagem na patela

Pode aliviar a dor **na hora**, para ajudar a fazer o exercício [4]. Os especialistas ainda têm dúvidas sobre o papel dela [3]. É apoio, não tratamento.

Joelheira

A diretriz americana **não recomenda** joelheira, faixa ou tala para a dor patelofemoral [4]. O consenso internacional considera a evidência incerta [3].

Aparelhos de fisioterapia isolados

Ultrassom, choque, laser e similares **não são recomendados** como tratamento [3][4].

E a cirurgia?

Sou cirurgião de joelho e, justamente por isso, digo: na dor patelofemoral comum, **a cirurgia raramente é indicada**. Num estudo com 56 pessoas, a artroscopia somada ao exercício **não foi melhor** que o exercício sozinho, e custou mais [12].

A cirurgia entra em situações específicas, como a patela que sai do lugar repetidas vezes, que é outro diagnóstico. E não é o caminho para tratar um laudo de "condromalácia" (opinião clínica).

Uma verdade que pouca gente conta

Um estudo holandês reencontrou, 5 a 8 anos depois, pessoas tratadas para dor patelofemoral: **mais da metade ainda relatava recuperação ruim**. Mesmo assim, 98% **não tinham artrose** no raio-X. Quem já tinha dor havia mais de 1 ano no começo evoluiu pior [6]. Limitação: só 60 dos cerca de 310 participantes iniciais foram reavaliados.

A mensagem é: **tratar cedo e com constância**, sem achar que o joelho está "se desgastando".

1. Achar que "condromalácia" é desgaste grave.

Alterações de cartilagem são comuns em quem não sente dor [7][8].

2. Parar de usar o joelho.

Repouso total enfraquece a coxa (opinião clínica). A base é exercício com carga ajustada [3][4].

3. Desistir do exercício em duas semanas.

Os estudos medem resultados em semanas a meses [9][10].

4. Confiar só na joelheira ou na palmilha.

O alívio é de curto prazo, quando existe [2][4].

5. Voltar à corrida ou à academia no volume antigo assim que a dor melhora.

Carga se ajusta e se devolve aos poucos [4][11].

Bônus: operar por causa do laudo. O laudo não explica a dor [7], e a artroscopia não superou o exercício [12].

Procure avaliação se:

- **Não há melhora clara após 6 semanas** de exercício bem feito.
- A dor já dura **mais de alguns meses**: dor antiga tende a ter evolução pior [6].
- O joelho **incha** com a atividade.
- A dor atrapalha o **sono**, o **trabalho** ou o **esporte** na maioria dos dias.
- Seu filho ou sua filha **adolescente** tem dor que se repete e está deixando de lado o esporte.
- **A qualquer momento**: apareceu algum sinal da Página 3.

O prazo de 6 semanas é bom senso clínico, não uma regra rígida.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico**: onde dói, o que piora, como a patela se movimenta, força do quadril e da coxa, alinhamento e testes de menisco e de ligamentos. Exame de imagem quando vai mudar a conduta. Só depois se decide o tratamento, e a decisão é tomada junto com você.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Crossley KM, Stefanik JJ, Selfe J, Collins NJ, et al. **2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: Terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures.** Br J Sports Med. 2016;50(14):839-843. doi:10.1136/bjsports-2016-096384. PMID: 27343241.
2. Crossley KM, van Middelkoop M, Callaghan MJ, Collins NJ, et al. **2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 2: recommended physical interventions (exercise, taping, bracing, foot orthoses and combined interventions).** Br J Sports Med. 2016;50(14):844-852. doi:10.1136/bjsports-2016-096268. PMID: 27247098.
3. Collins NJ, Barton CJ, van Middelkoop M, Callaghan MJ, et al. **2018 Consensus statement on exercise therapy and physical interventions (orthoses, taping and manual therapy) to treat patellofemoral pain: recommendations from the 5th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Gold Coast, Australia, 2017.** Br J Sports Med. 2018;52(18):1170-1178. doi:10.1136/bjsports-2018-099397. PMID: 29925502.
4. Willy RW, Hoglund LT, Barton CJ, Bolgia LA, et al. **Patellofemoral Pain: Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health From the Academy of Orthopaedic Physical Therapy of the American Physical Therapy Association.** J Orthop Sports Phys Ther. 2019;49(9):CPG1-CPG95. doi:10.2519/jospt.2019.0302. PMID: 31475628.
5. Smith BE, Selfe J, Thacker D, Hendrick P, et al. **Incidence and prevalence of patellofemoral pain: a systematic review and meta-analysis.** PLoS One. 2018;13(1):e0190892. doi:10.1371/journal.pone.0190892. PMID: 29324820.
6. Lankhorst NE, van Middelkoop M, Crossley KM, Bierma-Zeinstra SM, et al. **Factors that predict a poor outcome 5-8 years after the diagnosis of patellofemoral pain: a multicentre observational analysis.** Br J Sports Med. 2016;50(14):881-886. doi:10.1136/bjsports-2015-094664. PMID: 26463119.
7. van der Heijden RA, de Kanter JL, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, et al. **Structural abnormalities on magnetic resonance imaging in patients with patellofemoral pain: a cross-sectional case-control study.** Am J Sports Med. 2016;44(9):2339-2346. doi:10.1177/0363546516646107. PMID: 27206691.
8. Culvenor AG, Øiestad BE, Hart HF, Stefanik JJ, et al. **Prevalence of knee osteoarthritis features on magnetic resonance imaging in asymptomatic uninjured adults: a systematic review and meta-analysis.** Br J Sports Med. 2019;53(20):1268-1278. doi:10.1136/bjsports-2018-099257. PMID: 29886437.
9. van der Heijden RA, Lankhorst NE, van Linschoten R, Bierma-Zeinstra SM, van Middelkoop M. **Exercise for treating patellofemoral pain syndrome.** Cochrane Database Syst Rev. 2015;1:CD010387. doi:10.1002/14651858.CD010387.pub2. PMID: 25603546.
10. Lack S, Barton C, Sohan O, Crossley K, et al. **Proximal muscle rehabilitation is effective for patellofemoral pain: a systematic review with meta-analysis.** Br J Sports Med. 2015;49(21):1365-1376. doi:10.1136/bjsports-2015-094723. PMID: 26175019.
11. Esculier JF, Bouyer LJ, Dubois B, Fremont P, et al. **Is combining gait retraining or an exercise programme with education better than education alone in treating runners with patellofemoral pain? A randomised clinical trial.** Br J Sports Med. 2018;52(10):659-666. doi:10.1136/bjsports-2016-096988. PMID: 28476901.
12. Kettunen JA, Harilainen A, Sandelin J, Schlenzka D, et al. **Knee arthroscopy and exercise versus exercise only for chronic patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled trial.** BMC Med. 2007;5:38. doi:10.1186/1741-7015-5-38. PMID: 18078506.
13. Margaretten ME, Kohlwes J, Moore D, Bent S. **Does this adult patient have septic arthritis?** JAMA. 2007;297(13):1478-1488. doi:10.1001/jama.297.13.1478. PMID: 17405973.
14. Stiell IG, Greenberg GH, Wells GA, McDowell I, et al. **Prospective validation of a decision rule for the use of radiography in acute knee injuries.** JAMA. 1996;275(8):611-615. PMID: 8594242.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

